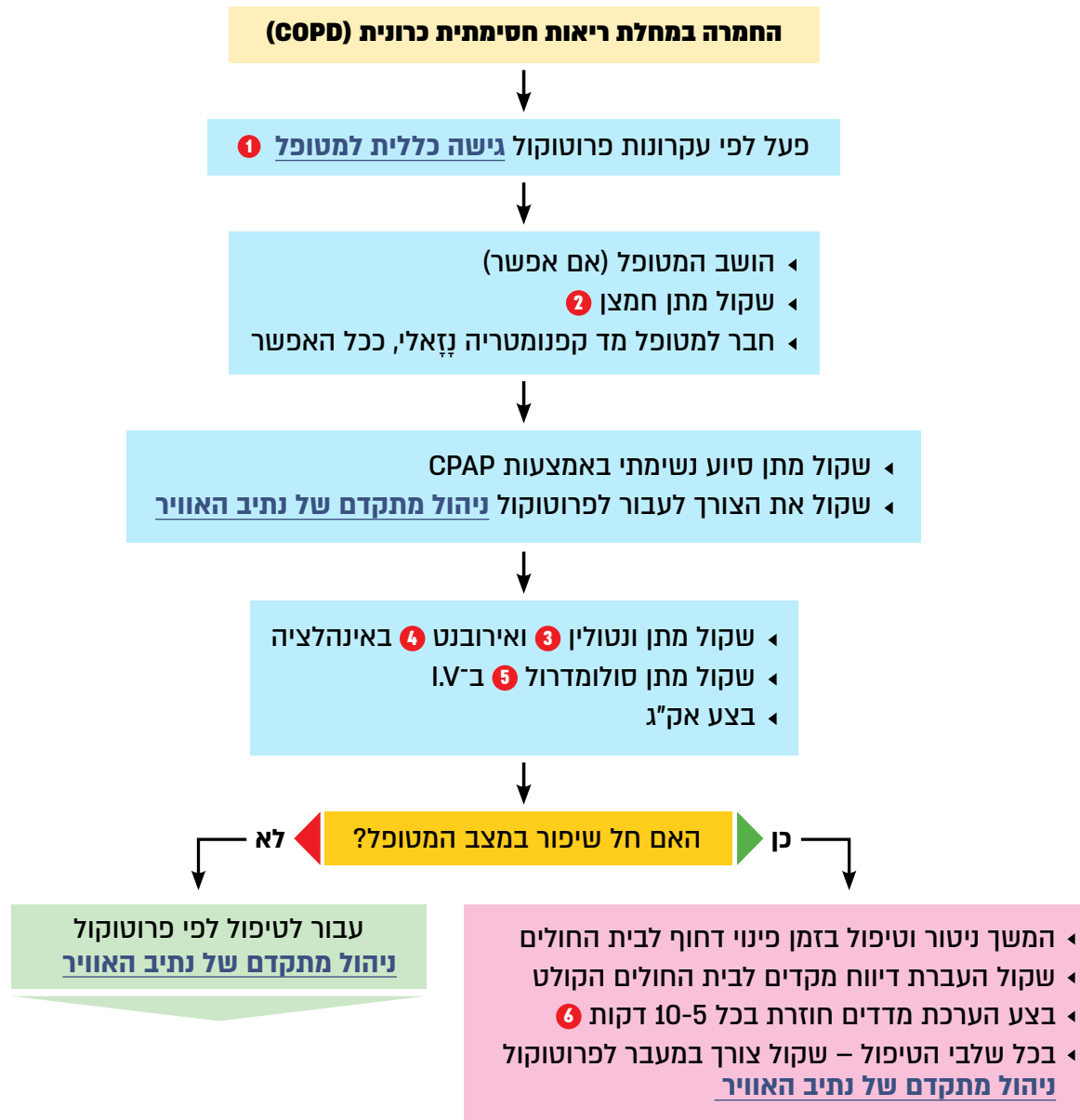


**1 הערכה ראשונית**

- + התרשמות כללית ממצב המטופל.
- + הערכת מצב הכרה.
- + הערכת קצב הנשימה ואיכותה.
- + מדידת קצב הדופק וסדירותו.
- + ערכי סטורציה וקפנומטריה.

2 מתן חמצן

- + כדי לשמור על ערכי סטורציה סביב 94%.
- + יש לנקוט משנה זהירות במטופלים בעלי נטייה לצבירת פחמן דו-חמצני CO₂.

3 ונטולין

- + באינהלציה – 2.5 mg מנה חד-פעמית.

4 אירובנט

- + באינהלציה – 0.5 mg מנה חד-פעמית.
- + יש למהול את התרופות ב-2 ml סליין.

5 סולומדרול

- + 125 mg מנה חד-פעמית.

6 מדדים לניטור

- + מצב הכרה.
- + מאמץ נשימתי.
- + סטורציה.
- + ערכי קפנומטריה נזאלית.
- + נצפה שיפור בערכי סטורציה.

החמרה ב־COPD

מתבטאת בהחמרה בקוצר הנשימה של המטופל, החמרה בשיעול, ריבוי ליחה ושינוי צבעה.

+ **גורמים להחמרה** – יכולה להיגרם מזיהומים בדרכי הנשימה העליונות, מריפלקס גסטרו־אזופגיאלי או מתסחיף ריאתי.

+ **סימנים וסימפטומים להחמרה במחלה** – טכיפניאה, טכיקרדיה, בלבול, שינוי במצב ההכרה, ירידה ביכולת התפקוד היומ־יומית, ירידה בערכי סטורציה.

מטרות הטיפול

+ זיהוי הגורם להחמרה במחלה וטיפול בו.

+ השבת תפקודי הריאה למצבם המיטבי.

+ שיפור החמצון ופינוי הפרשות.

+ הימנעות, ככל האפשר, מאינטובציה ומהנשמה מלאכותית.

שימוש במסכת CPAP

+ מטרת השימוש במסכה היא שמירה על ערכי הסטורציה מעל 90% במטופלים שמצבם לא השתפר על אף קבלת חמצן במסכה.

+ יש להקפיד על שימוש בערכי PEEP נמוכים (5 cm/H₂O).

+ אם המטופל מתעייף ונעשה ישנוני בזמן השימוש במסכה או שנצפית עלייה בערכי קפנומטריה – יש לשקול מעבר לפרוטוקול ניהול מתקדם של נתיב האוויר.